

ITEM 272 : SPLENOMEGALIE

Rate : 150 à 250 g chez l'adulte, en regard de la 10^{ème} côte, en dérivation entre la grande circulation et la circulation portale

- Fonctions: - **Régulation du flux sanguin**

- **Stockage** (30% de la masse plaquettaire)

- **Filtre** : hématies anormales, vieilles ou contenant des inclusions

- **Immunité** : **cellules lymphoïdes, macrophages** → production d'Ac, surtout contre les bactéries encapsulées

- **Organe hématopoïétique chez le fœtus** (entre le 3^e et 5^e mois)

→ Toute rate palpable est pathologique et nécessite une exploration étiologique

Diagnostic positif	Découverte	- Examen clinique, de manière fortuite ou devant un tableau évocateur : fièvre, hépatomégalie, ADP périphériques, hypertension portale, ictère cutanéomuqueux, anomalie de la NFS... - Troubles fonctionnels : - Pesanteur/douleur de l'HCG : à type de point de côté, augmentée à l'inspiration profonde, irradiant « en bretelle » vers l'épaule gauche - Gêne post-prandiale, constipation - Complication (rare) : - Infarctus splénique : douleur du flanc et/ou basi-thoracique gauche ± fièvre - Rupture de rate : choc hémorragique, souvent précédé de douleurs (rupture en 2 temps)	
	C	Palpation de la rate : patient allongé en décubitus dorsal, tête à l'horizontale, rate palpée avec la main posée à plat en oblique, le patient respirant profondément, les genoux fléchis - Splénomégalie : masse de l'hypochondre gauche, antérieure, superficielle, dont on palpe l'extrémité inférieure ± le bord antéro-interne crénelé, mobile à l'inspiration profonde, matité à la percussion, sans contact lombaire - Mesure de la splénomégalie : débord sous-costal = minime (1 à 2 cm), modéré (2 à 10 cm) ou massif (> 10 cm) - Splénomégalie majeure : peut atteindre la fosse iliaque et dépasser l'ombilic	
	DD	- Hypertrophie du lobe hépatique gauche - Gros rein gauche : masse postérieure, avec contact lombaire, immobile à l'inspiration profonde - Kyste ou tumeur de la queue du pancréas - Tumeur digestive ou mésentérique (tumeur de l'angle colique gauche : immobile, pôle inférieur mal limité) - Tumeur surrénale gauche - Cancer gastrique	
	PC	= Imagerie systématique : confirmation diagnostique si clinique non typique et bilan étiologique - Echographie abdominale : confirme la nature splénique de la masse, taille, forme (globuleuse et non concave), homogénéité (kyste, hématome), anomalie associée → Taille normale : 12 à 14 cm de grand axe x 4 à 8 cm d'axe transversal x 6 à 12 cm d'axe antéro-postérieur - TDM (en 2nd intention) : perte de la concavité, densité, homogénéité du parenchyme, nodules, ADP associée - Etude isotopique : intérêt fonctionnel, uniquement pour la mise en évidence d'une métaplasie myéloïde	
Etiologie	Infection	- Bactérienne : septicémie, fièvre typhoïde, tuberculose, endocardite infectieuse, brucellose - Virale : EBV, VIH, CMV, hépatite virale... - Parasitaire : paludisme, leishmaniose viscérale - Candidose hépatosplénique	
	Lésion ou obstacle pré-hépatique	- Cirrhose - Thrombose porte - Compression tumorale intra-hépatique - Hémochromatose	- Sarcoïdose - Bilharziose post-hépatique - Thrombose des veines sus-hépatiques (Budd-Chiari) - Insuffisance cardiaque droite
	Hématologique	- Hémolyse chronique (constitutionnelle ou acquise) - Syndrome myéloprolifératif : leucémie myéloïde chronique, splénomégalie myéloïde chronique, maladie de Vaquez, thrombocyémie essentielle, leucémie myélomonocytaire chronique - Syndrome lymphoprolifératif : lymphome, LLC, leucémie à tricholeucocytes - Leucémie aiguë → Absente en cas de myélome et de syndrome myélodysplasique (hors LMMC)	
	Pathologie inflammatoire	- Connectivite : lupus, sarcoïdose, syndrome de Gougerot-Sjögren - Maladie périodique : maladie de Still, fièvre périodique familiale... - Syndrome de Felty = polyarthrite rhumatoïde + splénomégalie + neutropénie sévère	
	Autres	- Métastase de tumeur solide - Traumatisme - Kyste - Hémangiome - Maladie de surcharge : amylose, hémochromatose, maladie de Gaucher, maladie de Niemann-Pick...	

Diagnostic étiologique	C		- Etat infectieux (fièvre, frisson) : infection ou hémopathie maligne (leucémie, lymphome), maladie de Still... - Signes d'hypertension portale : hépatomégalie, ascite, circulation veineuse collatérale - ADP périphérique : virose, sarcoïdose, hémopathie maligne - Ictère : hépatopathie, hémolyse - Examen des téguments : purpura et/ou leucémie (hémopathie), angine pseudo-membraneuse (MNI)...	
	PC		- En 1^{ère} intention : NFS + réticulocytes, frottis, Coombs direct, VS/CRP, bilan hépatique, EPP, bilan d'hémolyse - Selon les circonstances : hémoculture, frottis/goutte épaisse	
	NFS	Hyper-splénisme		= Manifestation pathologique de la splénomégalie, indépendante de la cause
			Cytopénie de séquestration	- Thrombopénie : fréquente, sans hémorragie, jusqu'à 50 G/L - Leucopénie globale (2-4 G/L) ou neutropénie (moins fréquente) - Anémie : habituellement modérée, avec petite composante hémolytique de stase (réticulocytes à 100-180 G/L) → Peut séquestrer jusqu'à 25% de la masse sanguine → Une splénomégalie importante peut diminuer l'efficacité des transfusions sanguines (notamment des plaquettes)
			Hémodilution	= Inconstante : par augmentation du débit sanguin traversant la rate, hypertension portale et stimulation du système rénine-angiotensine - Fausse anémie (masse globulaire totale inchangée) - Majoration d'une anémie préexistante : mesure isotopique de la masse globulaire et plasmatique dans les cas extrêmes
		Diagnostic étiologique	- Leucocytes : polynucléose neutrophile (infection bactérienne), leucopénie (infection virale, fièvre typhoïde, brucellose) ou lymphocytose avec lymphocytes stimulés (syndrome mononucléosique) - Macrocytose isolée ou anémie macrocytaire arégénérative : hépatopathie, hémopathie - Anémie régénérative : hémolyse - Thrombopénie : lié à l'hypersplénisme ou à l'étiologie (lupus, infection, hémopathie) - Polyglobulie, hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile et myélémie, hyperplaquettose chronique ou érythromyélie avec hématies en larmes (dacryocytes) : syndrome myéloprolifératif - Hyperlymphocytose > 4G/L chronique chez l'adulte > 40-50 ans : syndrome lymphoprolifératif - Cytopénie, cellules anormales (blastés, tricholeucocytes) : leucémie aiguë, syndrome myélo-dysplasique, leucémie à tricholeucocytes	
	Splénomégalie isolée sans signe d'orientation		- Myélogramme et/ou biopsie ostéo-médullaire : infiltration médullaire lymphomateuse, maladie de surcharge (rare), splénomégalie myéloïde chronique (myélofibrose), leucémie à tricholeucocytes - PET-scanner - Si toutes les investigations sont négatives : envisager la ponction-biopsie hépatique	
			Syndrome d'activation macrophagique	= Complique un déficit immunitaire (congénital ou acquis), une hémopathie maligne ou une infection virale (EBV, CMV, VIH) ou parfois bactérienne - Fièvre, hépatosplénomégalie, pancytopénie, ↑ LDH, hyperferritinémie, hypertriglycéridémie, cytolyse hépatique, coagulopathie de consommation - Myélogramme : phagocytose des cellules sanguines par les macrophages
	Splénectomie diagnostique		= En dernière intention : splénectomie avec exploration complète de l'abdomen, biopsie hépatique et de toute ADP intra-abdominale - Anatomopathologie : lymphome splénique primitif, maladie de surcharge, tumeur primitive... - Microbiologie : culture avec recherche de mycobactérie	
	Particularité de la NFS		- Pendant quelques semaines après la splénectomie : hyperleucocytose et hyperplaquettose - A vie : - Hématies à corps de Howell-Jolly (constante : affirme la splénectomie ou l'asplénie totale) - Thrombocytose discrète	
ASPLÉNIE	Risque infectieux		= Risque d'infection sévère, parfois foudroyante (septicémie, méningite), liées en particulier à des germes encapsulés : pneumocoque, méningocoque ou Haemophilus influenzae	
			Prophylaxie	- Vaccination anti-pneumococcique (Prevenar13® puis Pneumo23® après 2 mois) : idéalement 2 semaines avant splénectomie, sinon après 2 semaines - Vaccination anti-méningococcique (C ou ACYW135) - Vaccination anti-Haemophilus - Antibioprophylaxie par pénicilline V orale (Oracilline®) : jusqu'à l'adolescence chez l'enfant, ou pendant 1 à 2 ans chez l'adulte (discutée)
			En cas de fièvre	- Antibiothérapie probabiliste systématique : amoxicilline ou C3G à dose adaptée